DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO :	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU :	3658313
CALIDAD :	Original	FECHA :	31/05/2024 01:03
AREA :	U.E. Adulto	BOX :	Cama 2
HC :	2009374027	CTA. CTE. :	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : ROSA AMALIA VASQUEZ CONTRERAS **RUN** : 4.107.500-7 **CP** : 534193
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 05/09/1940 **Género** : Femenino **Edad** : 83 Años 8 Meses 26 Días
Dirección : 11 SEPT.LAS ENCINAS 0104 actualizado **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 988935551

DATOS INGRESO:

Procedencia : 1_EXTERIOR **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : A PIE O CAMINANDO

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 31/05/2024 01:15:49;

Profesional : Karina Neira Molina **Hra. Llamada** : 31/05/2024 01:15 **Hora Atención** : 31/05/2024 01:16
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 0 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 0 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C2
Motivo de consulta: : DISNEA, SAT: 89%- 90% FC: 102 X , PALIDA .
AM: ICC HTA DMII // EPA (2OPORTUNIDADES) IAM (2019)
ALERGIAS : NO
SE TOMA ECG EN TRIAGE

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
31/05/2024 01:36	105	170/110	36.2		26	93	191	JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 02:08	93	130/80			24	96		JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 03:04	103	130/80			32	93		JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 03:10	99	130/70	36.1		28	96		JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 03:49	125	120/80	36.3		24	96		JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 04:52	102	130/80	36.2		23	94		JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 07:40	127	120/70	36		22	95	140	JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 09:27	104	169/120	36		21	94	143	Lorena Hernandez Fuentes
31/05/2024 13:36	94	130/67	36.3		19	95	202	Lorena Hernandez Fuentes

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
31/05/2024 01:29	Paciente femenina de 83 años con antecedentes de: - ICC con FEVI severamente disminuida (25%) de etiología isquémica (IAM 2009) - HTA - DM2 no insulinorrequiriente - Dislipidemia - Artrosis - Duelo reciente Consulta por disnea. Al ingreso se constata: - Sibilancias espiratorias - Sin edema EEII ni ingurgitación yugular - ECG inicial con bloqueo de rama, que evoluciona a FA con RVR, respondiendo parcialmente a cedilanid logrando control de frecuencia pero persistiendo en FA. Exámenes destacan: - Troponina 188 - Dímero D 1700	Felix Antonio Sanhueza Luna
31/05/2024 02:22	Pcte vigil, cooperadora, en compañía de hija, presenta patrón subcostal, disnea en reposo, 3/10 BORG y sensación de ahogo (refiere que menos que al momento de llegar a UE), esta con apoyo de O2 por naricera a una fiO2 de 28%, Sat: 97-98% FC: 98, FR: 27x min. Presenta tos húmeda. Ausc: Mp(+) disminuido globalmente + sibilancias globales en ambos tiempos. Se encuentra con hospitalización abreviada con BI ciclos cada 20 min-SBT 3 ciclos cada 20 min. Se apoya con ejercicios ventilatorios a pcte. Sin incidentes.	LEANDRO ELISEO NOVA CARRASCO
31/05/2024 05:43	se informa valor tropo 160 (menor que previo)	Felix Antonio Sanhueza Luna
31/05/2024 08:24	entreado del caso ant de fa sin taco en espera de angiotac pr dimero d elevado tto: carvediolol 25 mg 1 cada 12 horas furosemida 40 mg 1 por dia hidralazina 50 mg 1 cada 8 horas isosorbide 10 mg 1 cada 10 horas espironolactona 25 mg 1 por dia valsaratn/sacubitrilo 50 mg 1 cada 12 horas empaglifozina 10 mg por dia. ahora mejor, menos molestias.	MANUEL VALDES SALGADO
31/05/2024 09:31	EVALUADA POR MEDICO UTI POR ESTABILIDAD HEMODINAMICA POR TEP MARGINAL Y SIN MOLESTIAS CLINICAS SE RECOMIENDA MANEJO POR HODOM DEJANDO DABIGATARN 110 MG 1 CADA 12 HORAS VIA ORAL. Y SE SOLICITA PANEL VIRAL.	MANUEL VALDES SALGADO

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional
31/05/2024 01:29	mp+sibilancias espiratorias. no ausculto crepitaciones afebril	Felix Antonio Sanhueza Luna

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
31/05/2024 08:26	pendiente informe de angiotac por sospecha de tep	MANUEL VALDES SALGADO
31/05/2024 09:31	I82.9 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA	MANUEL VALDES SALGADO

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable

31/05/2024 01:31	influenza/covid	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 01:49	Maritza Yasmin Biernay Morales
31/05/2024 01:31	hidrocortisona 300 mg ev	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 01:44	Roberto Concha Vega
31/05/2024 01:32	b ipratropio 4 puff cada 20 minutos x 5 alternados con salbutamol 2 puff cada 20 min x 3	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 01:51	JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 01:32	kinesioterapia respiratoria	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 03:40	Paz Valentina Del Solar Reveco Obs:KLGO LEANDRO ELISEO NOVA CARRASCO
31/05/2024 01:34	mni y control frecuente de PA	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 01:51	JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 01:34	furosemida 20 mg ev	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 01:45	Roberto Concha Vega
31/05/2024 03:13	CEDILANID 0,4 MG EV	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 03:19	Maritza Yasmin Biernay Morales Obs:EU ROBERTO CONCHA
31/05/2024 05:18	angiotac de torax	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 10:28	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES Obs:TAC
31/05/2024 06:20	ss 09% 250 cc ev + paracetamol 1 g ev	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 06:51	Maritza Yasmin Biernay Morales
31/05/2024 06:20	lanatosido c 0,4 ev	Felix Antonio Sanhueza Luna	Ejecutado el 31/05/2024 06:51	Maritza Yasmin Biernay Morales Obs:06:30
31/05/2024 08:19	PENDIENTE INFORME DE TAC	MANUEL VALDES SALGADO	Ejecutado el 31/05/2024 09:56	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES Obs:TAC
31/05/2024 08:26	carvedilol 25 mg por dia via oral, hidralazina 50 mg 1 via oral	MANUEL VALDES SALGADO	Ejecutado el 31/05/2024 08:46	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/05/2024 08:26	clexane 60 mg sc	MANUEL VALDES SALGADO	Ejecutado el 31/05/2024 08:46	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/05/2024 12:13	tomar paner viral y manetener en hodom.	MANUEL VALDES SALGADO	Ejecutado el 31/05/2024 12:48	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
31/05/2024 01:33	RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; PERFIL BIOQUIMICO ; E.L.P. ; PCR ; TTPK ; INR ; LDH ; GASES ARTERIALES ; AC. LACTICO ; TROPONINA I ; OTROS ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
31/05/2024 05:18	TROPONINA I ;	Felix Antonio Sanhueza Luna
31/05/2024 12:14	OTROS ;	MANUEL VALDES SALGADO
31/05/2024 05:19	ANGIOTC. DE TORAX,RX T?RAX FRONTAL Y LATERAL	Felix Antonio Sanhueza Luna

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
31/05/2024 09:31	HOSPITALIZAR EN HODOM DABIGATARN 110 MG CADA 12 HORAS VIA ORAL. carvediolol 25 mg 1 cada 12 horas furosemida 40 mg 1 CADA 12 HORAS hidralazina 50 mg 1 cada 8 horas isosorbide 10 mg 1 cada 10 horas espironolactona 25 mg 1 por día clexane 60 mg sc cada 12 horas sc valsartan/sacubitrilo 50 mg 1 cada 12 horas POR ESTABILIDAD HEMODINAMINA Y DESPUES DE EVOLUACION POR UTI, SE DECIDE MANEJO POR HODOM rescatar panel viral.	MANUEL VALDES SALGADO

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
31/05/2024 12:14	dabigatran 110 mg 1 cada 12 horas por 1 mes	MANUEL VALDES SALGADO

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
31/05/2024 01:45	SE INSTALAN VVP#16 EN BRAZO DERECHO.	Roberto Concha Vega
31/05/2024 01:52	Tratamiento crónico Carvedilol 25 mg cada 12 hrs Furosemida 40 mg/día hidralazina 50 mg cada 8 hrs Isosorbida 10 mg cada 8 hrs Espironolactoma 25 mg/día Valsartan 50 mg cada 12 hrs Empagliflozina 10 mg/día Omeprazol 20 mg/día Paracetamol 500 mg 2 comp/día ATV 40 MG /día Metformina 500 mg/día AAS 100 MG/día	Maritza Yasmin Biernay Morales
31/05/2024 01:56	PACIENTE FEMENINA CON ANTECEDENTES DE DM NO IR- ICC- EPA(2 OPORTUNIDADES)- IAM (2019), SIN ALERGIAS CONOCIDAS. ACUDE HOY A LA UE POR TOS DE DOS DIAS DE EVOLUCION Y REFIERE QUE DESDE HOY EN LA NOCHE DE INICIO SUBITO CON SIBILANCIAS Y DISNEA POR LO QUE CONSULTA. A SU INGRESO HIPOSATURANDO 89-90% SE PASA A SALA DE OBSERVACION PARA MONITORIZACION Y SE APOYA CON 2 LITROS POR NRC LOGRANDO SATURACION DE 96%, HIPERTENSA, TAQUICARDICA, TAQUIPNEICA, AFEBRIL, LEVE HIPERGLICEMIA CAPILAR. AL EXAMEN FISICO GLASGOW 4+5+6=15 PTS, TRANQUILA, COOPERADORA PIEL TIBIA LLENE CAPILAR MENOR A 2SEG, PIRRL, YUGULARES PLANAS, TORAX SIMETRICO CON DISNEA AL MINIMO ESFUERZO CON USO DE MUSCULATURA ACCESORIA, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE DOLOROSO A LA PALPACION DIFUSO, MOVILIZA 4 EXTREMIDADES SIN DIFICULTAD, EDEMA (-).	Maritza Yasmin Biernay Morales
31/05/2024 01:58	SE INICIA TERAPIA DEPLETIVA CON FUROSEMIDA + TERAPIA BRONCODILATADORA+ HIDROCORTISONA 300 MG. SE AVISA A KINESIOLOGO PARA EVALUACION, REFIERE USO DE PROTESIS DENTAL (NO LA TRAE).	Maritza Yasmin Biernay Morales
31/05/2024 01:59	***CONTACTO*** ROSA ACUÑA HIJA 988935551	Maritza Yasmin Biernay Morales
31/05/2024 03:02	SE TOMA ECG SEGUN INDICACION MEDICA, POR VALOR CRITICO DE TROPONINA.	Roberto Concha Vega
31/05/2024 03:06	CSV DE LAS 03:04 NO CORRESPONDE A PACIENTE	JACQUELINE VILLANUEVA SILVA
31/05/2024 03:13	SE AVISA A MEDICO QUE MONITOR EVIDENCIA AC X FA CRVR, RITMO ENTRE 130-160 X .	Roberto Concha Vega
31/05/2024 09:28	CSV INTERNA TENS INACAP MILLARAY TRONCOSO	Lorena Hernandez Fuentes
31/05/2024 09:29	Impresión: Tromboembolismo pulmonar agudo en rama segmentaria medial y posterior basal derecha. Cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas y signos de falla cardíaca derecha. Engrosamientos septales difusos con opacidades en vidrio esmerilado centrales bilaterales	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES

	asociado con leve derrame pleural bilateral. Múltiples quistes pulmonares difusos	
31/05/2024 10:27	Se recibe pcte en cama 2 monitorizada en espera de AngioTAC de tórax (que se rescata), en BCG, al csv hipertensa, resto ok, normosaturando sin apoyo de O2 adicional. Al EF glasgow 15 pto, tranquila, yugulares planas, destaca leve disnea de esfuerzo. Presento informe de TAC a médico de turno quien presenta a médico UPC. Se mantiene acompañada por familiar, en espera de evaluación por UTI.	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/05/2024 16:07	Paciente es evaluada durante la mañana por médico UTI quien sugiere HODOM, pcte HDE, sin dolor, es dada de alta con TACO. Se entrega documentación.-	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES

GES	:	No	**PERTINENCIA**	:	Si	**DESTINO**	: Domicilio

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600·360·7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

www.hospitalsancarlos.cl
Fono: +56 42 2586130

ORIGINAL: PACIENTE
248105211158

MANUEL VALDES SALGADO
13.859.840-3